



Universidad de
La Sabana

Acreditación
Institucional
de Alta Calidad

10
años

LABORATORIO DE GOBIERNO

Orgullosamente
UniSabana

Modelo de analítica de datos para la toma de decisiones en salud

Clínica Universidad de La Sabana

Noviembre 2025



Objetivos del estudio

- Analizar la **demanda de servicios de salud en el área de influencia** de la clínica, con base en la información de los actuales pacientes NO EPS.
- **Definir patrones de demanda y segmentación de usuarios** según los perfiles sociales y económicos de los pacientes
- **Identificar oportunidades de mercado** entre pacientes no afiliados a EPS, considerando su ubicación geográfica y tipo de aseguramiento en salud.

Data analizada

- 450.000 Facturas desde 2023
- 45.000 Pacientes únicos
- 20.000 polígonos catastrales
- +100 municipios
- +1'000.000 de vías de acceso

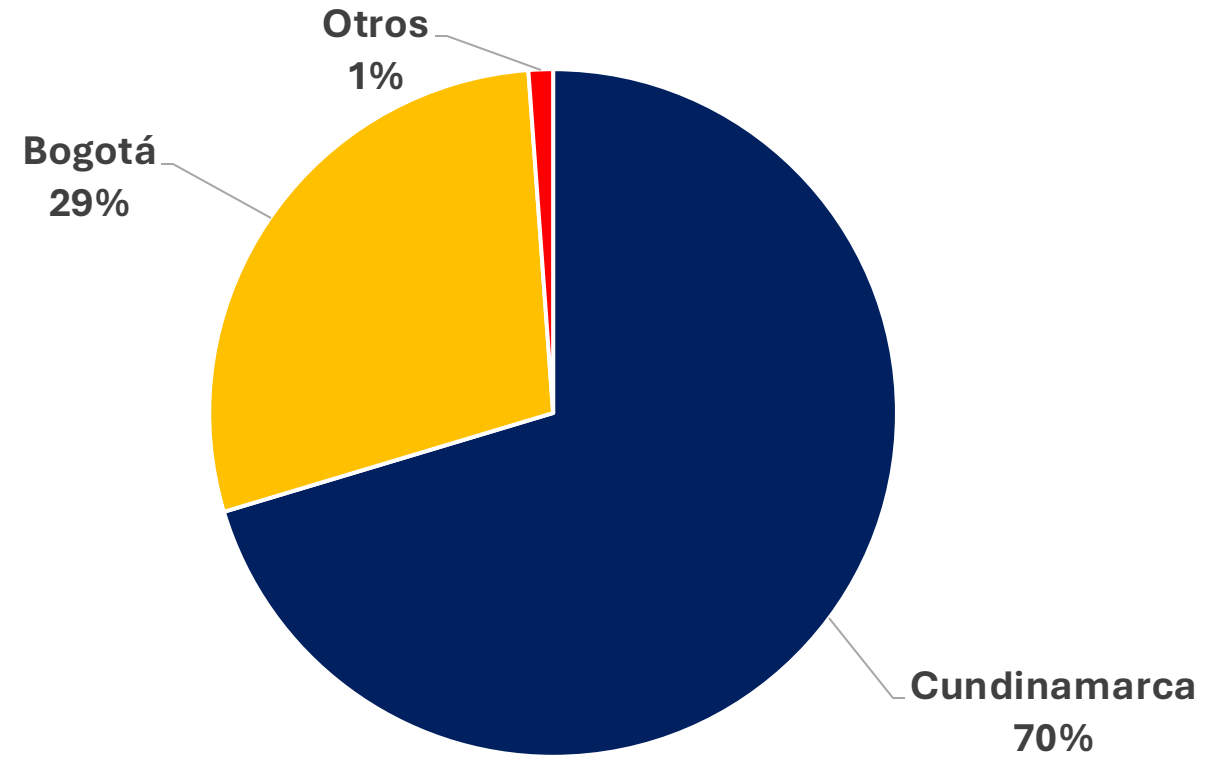
Análisis geoespacial

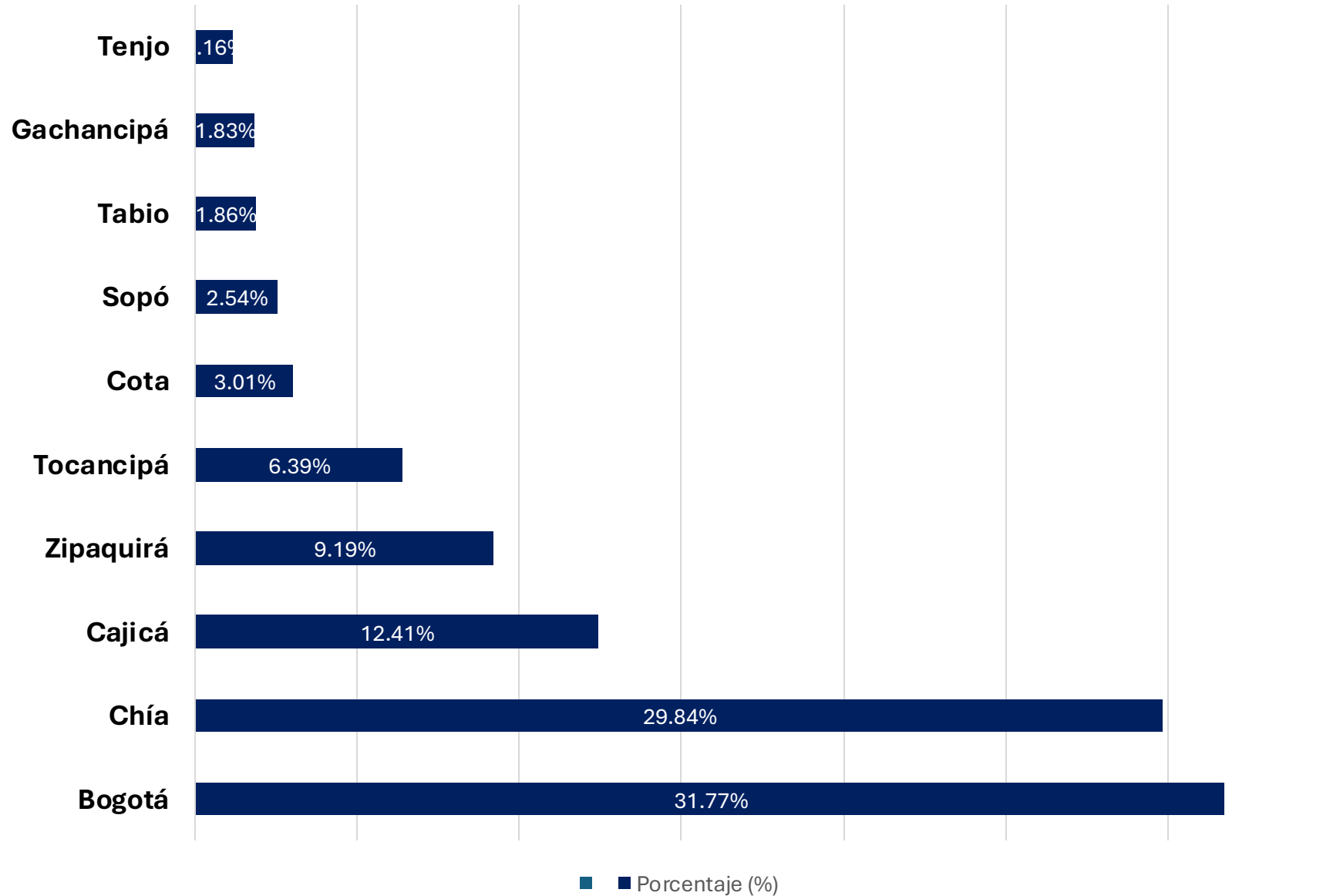
Ubicación geográfica de los pacientes



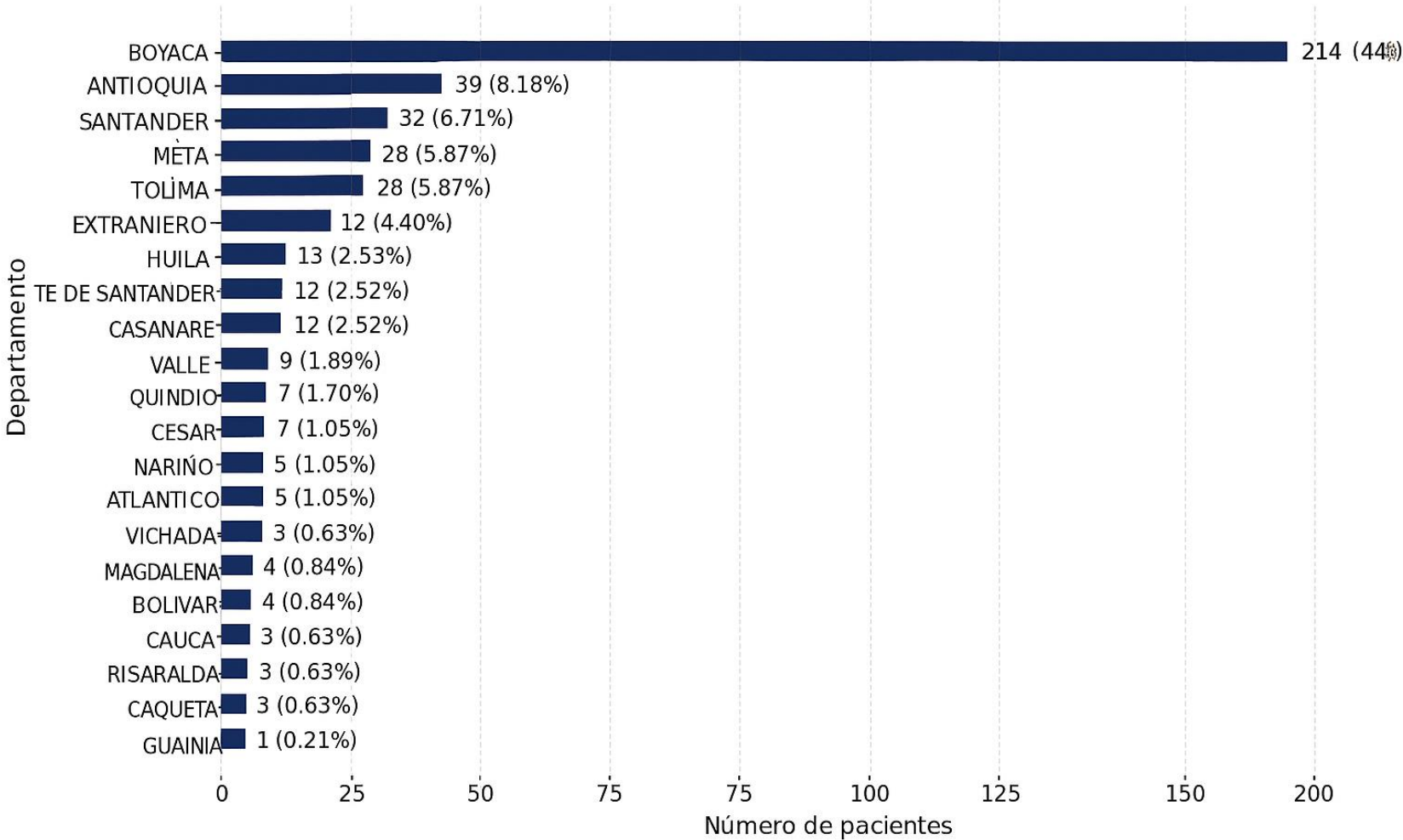
99%

De los pacientes residen en Bogotá y Cundinamarca.

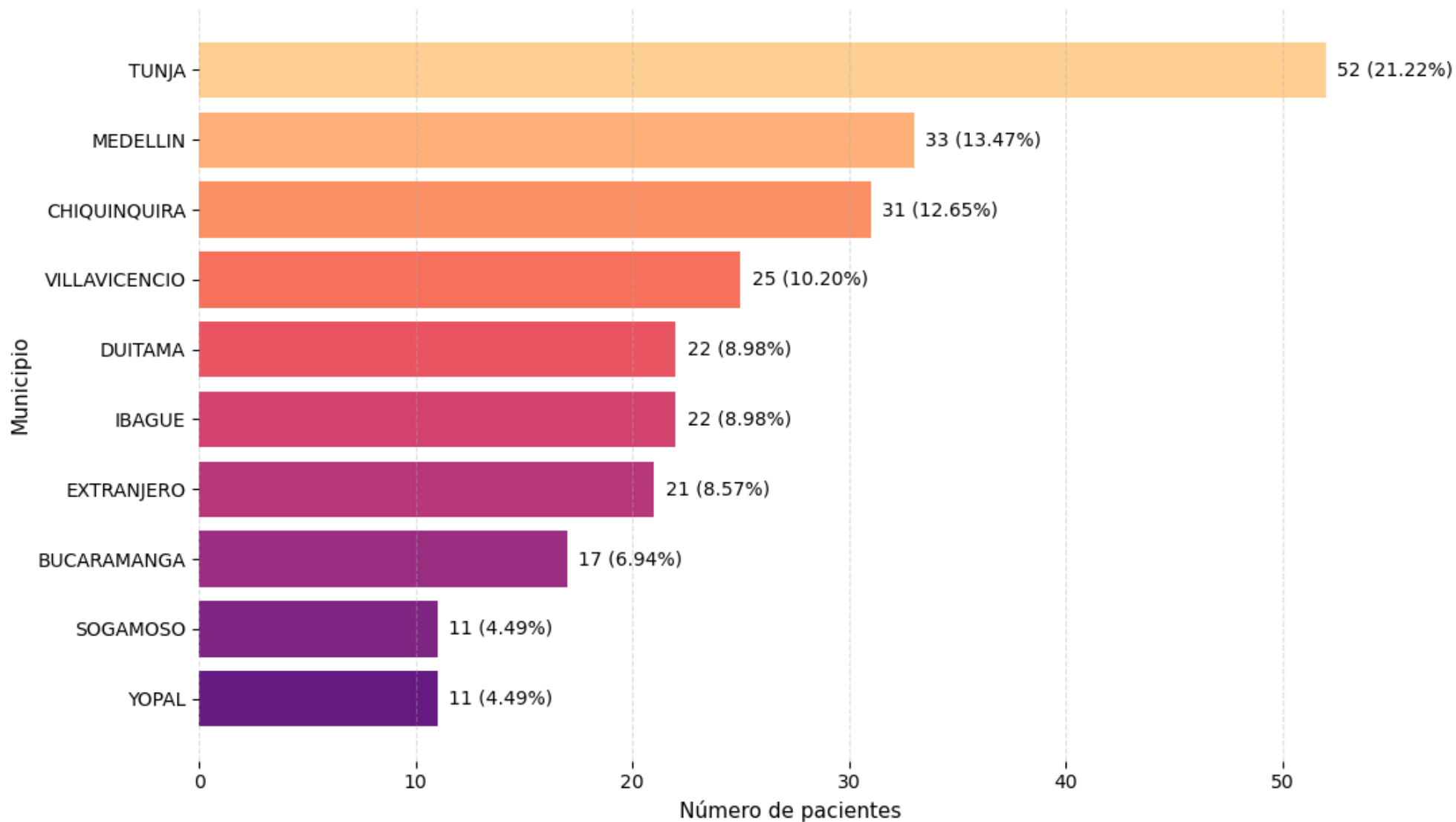




**Distribución de personas dentro de la categoría 'OTROS'
por Departamento de Residencia**



Top 10 municipios con mayor número de pacientes (excluyendo BOGOTÁ y CUNDINAMARCA)



Isocronas o Anillos de influencia

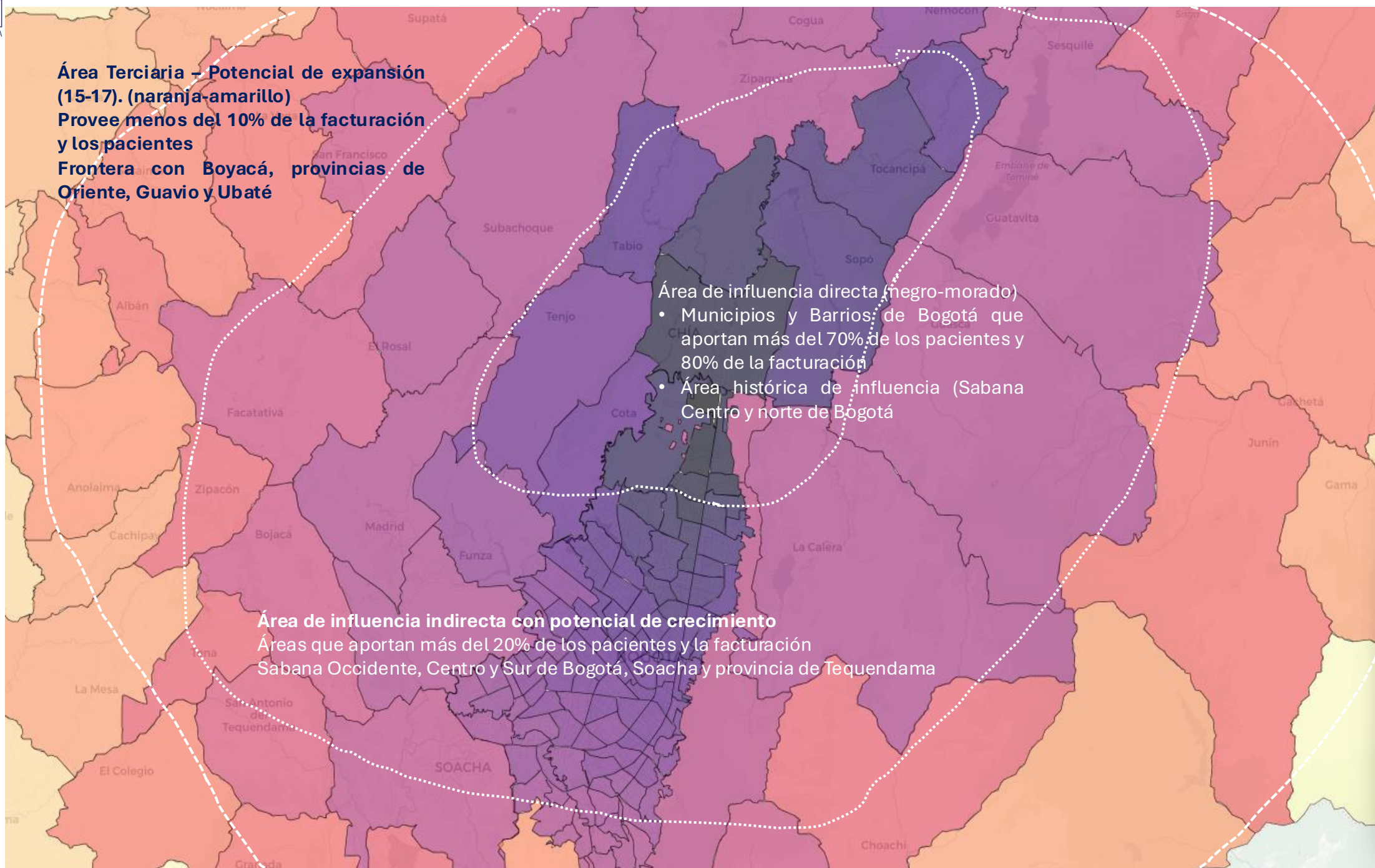
**Área Terciaria – Potencial de expansión
(15-17). (naranja-amarillo)**
**Provee menos del 10% de la facturación
y los pacientes**
**Frontera con Boyacá, provincias de
Oriente, Guavio y Ubaté**

Área de influencia directa (negro-morado)

- Municipios y Barrios de Bogotá que aportan más del 70% de los pacientes y 80% de la facturación
- Área histórica de influencia (Sabana Centro y norte de Bogotá)

Área de influencia indirecta con potencial de crecimiento

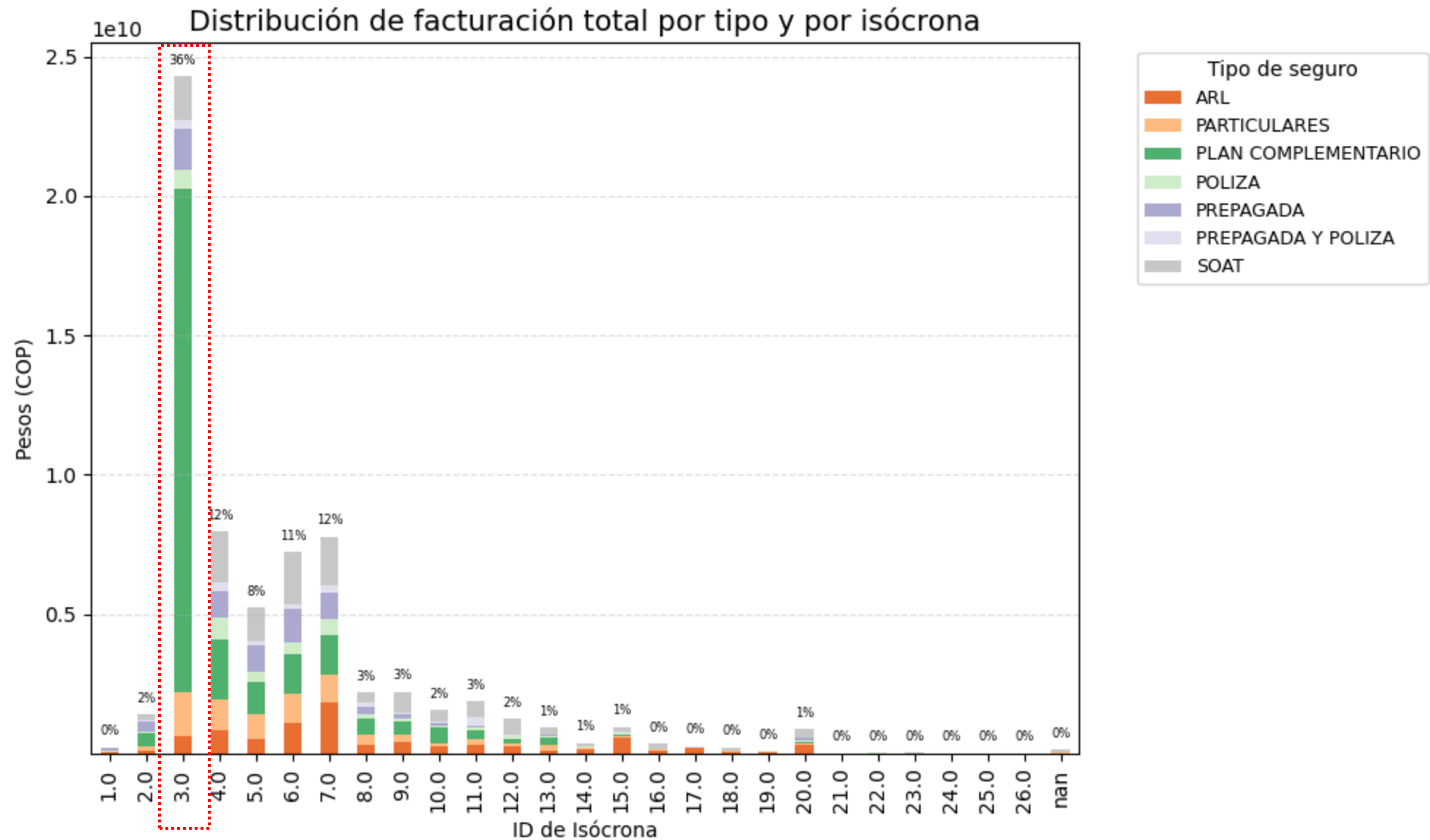
Áreas que aportan más del 20% de los pacientes y la facturación
Sabana Occidente, Centro y Sur de Bogotá, Soacha y provincia de Tequendama



El cinturón de oro

Área donde la clínica atiende el 18% de los pacientes quienes a su vez le representan el 36% de la facturación

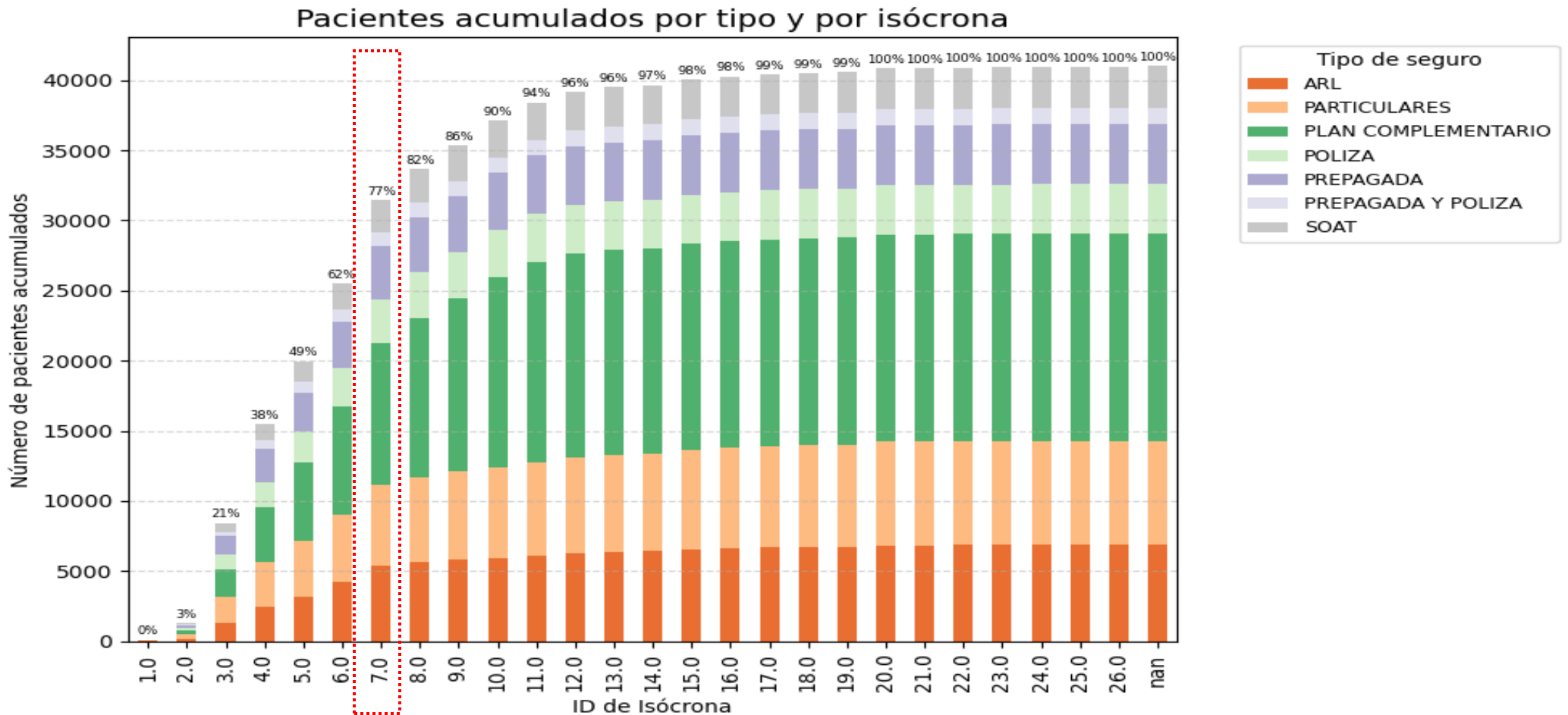
Chía Centro, Cajicá, Yerbabuena, Aposentos y entre la calle 185 y la 222 en Bogotá



Bogotá Borde Norte - Zipaquirá

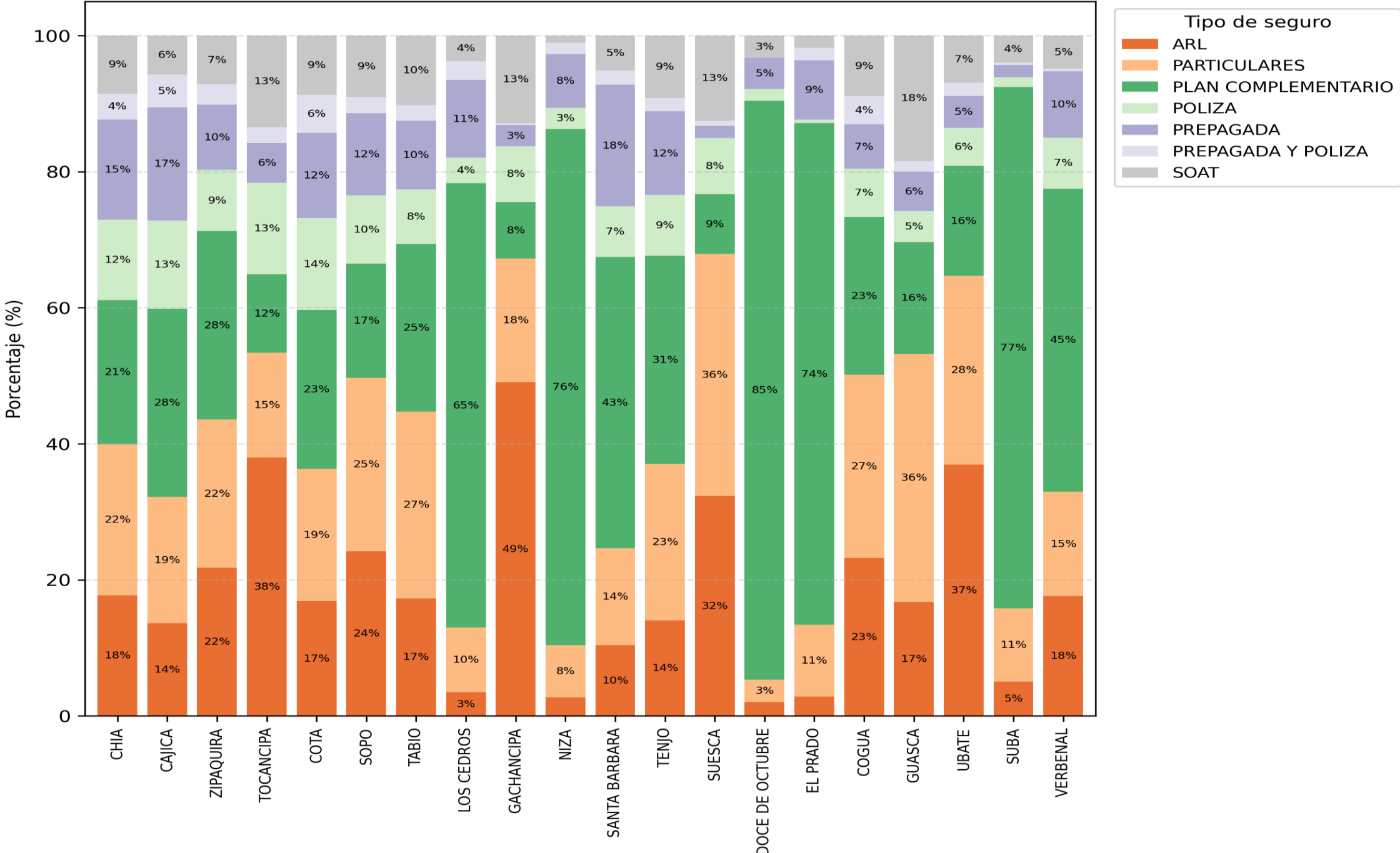
Área que representa el 77% de los pacientes y el
80% de la facturación

Municipios de Sabana Centro y la frontera norte de Bogotá (desde calle 80)



Perfiles de pacientes **no-EPS** por tipo de aseguramiento -Bogotá Borde Norte y Sabana Centro-

Distribución porcentual de pacientes por tipo en cada zona



Zona (UPZ o municipio)	Tipo(s) de seguro predominante(s)	Observaciones relevantes
Chía, Cajicá y Zipaquirá	Plan complementario y particulares	Alta participación de planes privados (entre 40% y 50%).
Tocancipá y Cota	Plan complementario y ARL	Mezcla entre afiliaciones empresariales y particulares.
Sopó y Tabio	Plan complementario	Más del 60% de los pacientes pertenecen a este tipo de plan.
Los Cedros y Gachancipá	Plan complementario y prepagada	Fuerte concentración en servicios privados.
Niza y Santa Bárbara	Plan complementario	Alta proporción (superior al 70%).
Tenjo y Suesca	Plan complementario y ARL	Participación balanceada entre seguros laborales y privados.
Doce de Octubre y El Prado	Plan complementario	Concentran la mayor proporción (hasta 85%).
Cogua y Guasca	Plan complementario y particulares	Alta presencia de servicios individuales.
Ubaté y Suba	Plan complementario y ARL	Zonas con presencia mixta y menor peso de particulares.
Verbenal	Plan complementario	Mantiene la tendencia general de predominio de seguros privados.

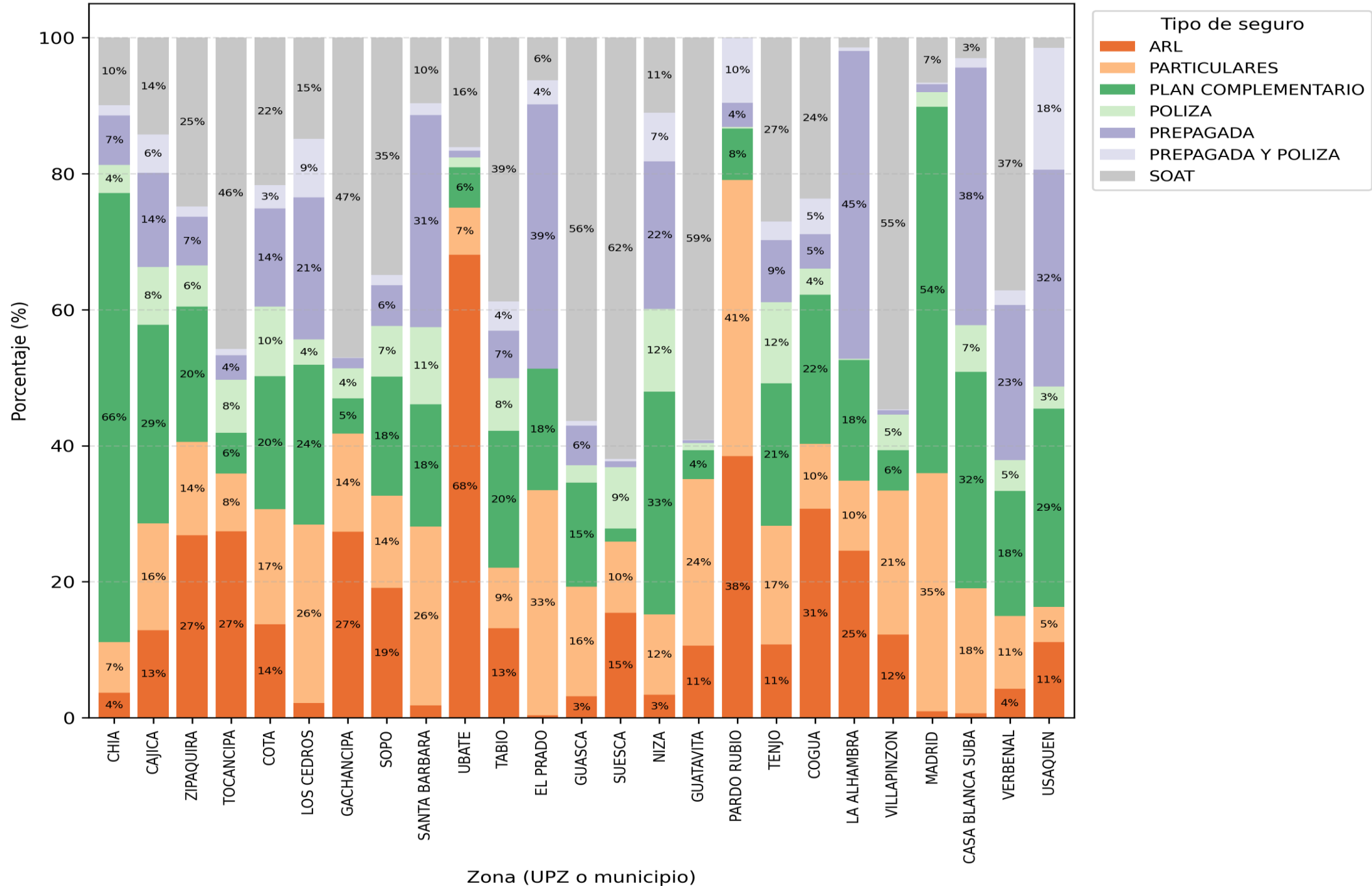
- El **plan complementario** es el tipo de seguro más representativo en casi todas las zonas, alcanzando porcentajes superiores al 60% en varias de ellas.
- En **zonas rurales o semiurbanas** (como Ubaté, Suesca o Cogua), se observa una mayor participación de **ARL y SOAT**, lo que podría relacionarse con actividades laborales o accidentes de tránsito.
- Los **pacientes particulares** tienen una mayor representación en **municipios más cercanos** a Bogotá, como Chía o Cajicá.

Ingresos a la clinica segun tipo de aseguramiento del paciente No EPS

Tipo de seguro	% de pacientes	% de facturación
Plan complementario	36,10%	40,50%
Particulares	18,10%	11,00%
ARL	16,70%	11,70%
Prepagada	10,50%	10,30%
Póliza	8,60%	5,20%
SOAT	7,20%	18,40%
Prepagada y póliza	2,80%	2,90%

- El **plan complementario** es el principal segmento, con la mayor proporción tanto de pacientes como de facturación
- El **SOAT** presenta un alto valor económico relativo, generando 18,4% de la facturación con solo 7,2% de los pacientes.
- Los **pacientes particulares son** numerosos (18,1%) pero con baja participación en ingresos (11%), lo que sugiere servicios de menor costo promedio

Distribución porcentual de facturación total por tipo en cada zona (1-25)



Tendencia general	Observaciones principales
Plan complementario	Predomina en la mayoría de las zonas, destacándose especialmente en Chía, Cota, Santa Bárbara, Cogua, Madrid, Casa Blanca y Suba, donde concentra más del 50% de la facturación.
Particulares	Tienen una presencia relevante en zonas como Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá y Guatavita, reflejando demanda de servicios de pago directo.
ARL y SOAT	Aunque su participación es menor en volumen de pacientes, en algunas zonas rurales o industriales como Suesca, Ubaté y Gachancipá, alcanzan proporciones significativas de la facturación (más del 30%), posiblemente por atenciones derivadas de accidentes laborales o de tránsito.
Prepagada y póliza	Representan una porción reducida en la mayoría de zonas, pero con presencia constante en sectores de mayor nivel socioeconómico como Usaquén y Verbenal.

- La facturación se concentra principalmente en planes **complementarios y pacientes particulares**
- Predominio geográfico del plan complementario: Este tipo de aseguramiento lidera la facturación en **zonas urbanas y de mayor poder adquisitivo** –como Chía, Cota, Santa Bárbara (Bta), Madrid y Suba– donde supera el 50% de participación.
- En municipios **periféricos e industriales** (como Ubaté, Suesca, Gachancipá y Guatavita), los seguros **SOAT y ARL** registran una participación significativa en la facturación, asociada a servicios derivados de accidentes laborales y de tránsito

Se evidencia un potencial de **crecimiento sostenido en servicios particulares, pólizas y prepagadas**, especialmente en **zonas con alto dinamismo poblacional** como Chía, Cajicá, Cota, Zipaquirá, Madrid y Suba, donde el crecimiento urbano, la expansión residencial y la llegada de población con mayor capacidad adquisitiva.

Estas áreas representan oportunidades para ampliar la cobertura territorial, fortalecer la presencia institucional y diversificar la base de usuarios.

Áreas estratégicas de **expansión y crecimiento** de la clínica

Se identifican cinco zonas de interés estratégico con alto potencial de desarrollo y crecimiento de la demanda en servicios NO EPS:

1. **Lagos de Torca** (Calle 222): Futuras urbanizaciones con amplia proyección residencial y alto potencial para servicios privados de salud.
2. **San José de Bavaria**: Sectores de estratos 4, 5 y 6 con baja cobertura actual, ideales para ampliar la presencia institucional.
3. **Yerbabuena, Aposentos y Briceño**: Concentración de residentes de estratos altos (5 y 6), con alta afinidad hacia planes complementarios, pólizas y prepagadas.
4. **Funza**: Municipio con creciente demanda de servicios ARL y particulares, asociado al desarrollo industrial y logístico de la zona.
5. **Zipaquirá y Tocancipá**: Áreas de expansión urbana dinámica, con oportunidades para captar nuevos usuarios, aunque presentan niveles de saturación parcial en algunos sectores.

LABORATORIO DE GOBIERNO



UNIVERSIDAD DE LA SABANA

